IMPLANTE DENTÁRIO IMEDIATO PARA REABILITAÇÃO DE DENTE TRAUMATIZADO



Maria Eduarda Godinho Peixoto[1], Matheus Carvalho Gomes[2] e Walace Casadio de Oliveira[3]

1. Acadêmico de Graduação em Odontologia, Afya Universidade UNIGRANRIO, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil.
2. Acadêmico de Graduação em Odontologia, Afya Universidade UNIGRANRIO, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil.
3. Professor de Graduação em Odontologia, Afya Universidade UNIGRANRIO, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil.

Email do autor (a): mariaeduardagodinhopeixoto@gmail.com

Palavras-chave: Cirurgia guiada; Carga imediata; Implante dentário; Reabsorção radicular

INTRODUÇÃO

A reabsorção radicular decorrente de traumatismos pode levar à perda dentária, mesmo muitos anos após o trauma, tornando a reabilitação de dentes anteriores um desafio. Nesse contexto, a instalação imediata de implantes associada à cirurgia guiada pode proporcionar maior precisão no posicionamento do implante e maior previsibilidade estética e funcional do trabalho protético final.

OBJETIVOS

Relatar um caso de instalação de implante imediato, com carga imediata, através de cirurgia guiada, para substituição de um incisivo central com histórico de trauma dentário.

RELATO DE CASO

Paciente M.S.P.S., 70 anos, com histórico de trauma dentoalveolar há 30 anos, procurou atendimento particular para avaliação do elemento 21. Os exames de imagem evidenciaram extensa reabsorção radicular, com indicação para exodontia minimamente invasiva e instalação imediata de implante. O planejamento foi realizado digitalmente no software Exoplan 3.1, possibilitando a cirurgia guiada. Após a exodontia com alavancas e periótomos, foi instalado um implante S.I.N. STRONG SW CM 3,8 × 10 mm 16°, com torque de 50 N.cm, possibilitando seu carregamento imediato. A coroa do dente extraído foi utilizada como provisória e fixada com resina composta sobre um pilar provisório, aparafusado, de titânio. Após o período de osseointegração, a reabilitação protética foi realizada com uma coroa cerâmica E-max.





Figura 1: Aspecto radiográfico e clínico iniciais

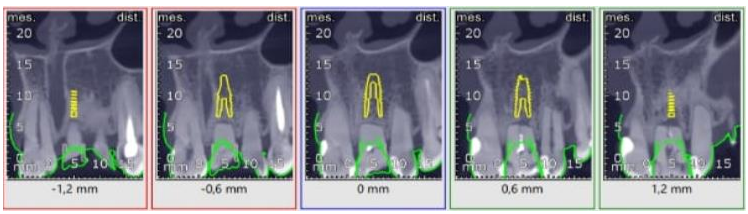


Figura 2: Planejamento digital – Plano Frontal

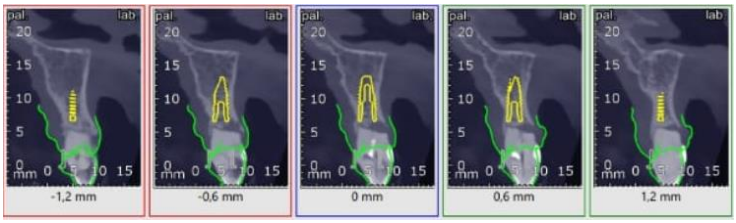


Figura 3: Planejamento digital – Plano Sagital



Figura 4: Guia cirúrgico



Figura 5: Coroa provisória

DISCUSSÃO

A instalação e provisionalização imediatas de implantes em zona estética mostrou-se previsível com o planejamento guiado, reforçando os achados de *Meng, Chien e Chien (2021)*. A elevada estabilidade primária, com torque de 50 N.cm, foi determinante para essa abordagem, atendendo aos critérios de *Resnik (2022)*.

CONCLUSÃO

O planejamento permitiu a preservação da tábua óssea vestibular e do contorno e volume gengival, além de proporcionar elevada estabilidade primária do implante. A reabilitação definitiva com coroa cerâmica apresentou resultado estético e funcional satisfatório, demonstrando a previsibilidade da técnica.



Figura 6: Saída do parafuso



Figura 7: Resultado final

REFERÊNCIAS